

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Université Saleh Bounider Constantine 3

Faculté de médecine

Département de Médecine



La Sporotrichose

«Maladie des éleveurs de roses»

Elaboré par Dr MERADJI ASSIA

➤ **Définition:**

-mycose subaigüe ou chronique cutanéolymphatique.

- faisant suite à l'inoculation traumatique dans le derme des spores d'un champignon dimorphique, *Sporothrix schenckii*.

-Les formes disséminées peuvent se voir chez les immunodéprimées.

➤ **Agent causal**

-**Sporothrix schenckii**: champignon dimorphique

Il se trouve dans la nature : sur les plantes, dans le sol, l'eau et l'air, certains animaux comme le chat, le chien ou le cheval peuvent le véhiculer.

➤ **Répartition géographique :**

- sporadique en Algérie ; fréquent en zones tropicales et subtropicales.

➤ **Mode de contamination :**

-l'inoculation cutanée est généralement d'origine traumatique : l'effraction cutanée ou muqueuse à la suite de blessures par échardes ou nageoires de poissons, de morsure animale ou de piqûre d'arthropodes.

-Ce qui explique la localisation fréquente aux membres supérieurs ou aux parties découvertes.

-Plus rarement, des formes pulmonaires sont dues à des contaminations par inhalation de poussières contaminées par le champignon.

- plus fréquente chez les hommes ; une maladie professionnelle chez les fermiers, les jardiniers et les horticulteurs ;

➤ **Clinique :**

-lésions **nodulaires cutanées et sous cutanées** siégeant dans 80 % des cas sur les membres, parfois au niveau du visage et du cou.

-La lésion initiale (15J) : nodule dur, indolore sauf s'il se situe sur le visage, devenant ulcéreux et croûteux (chancre sporotrichosique).

-La guérison spontanée est possible mais dans 80 p. 100 des cas, l'évolution se fait vers la forme: **Cutanéolymphatique**

-Forme **Cutanéolymphatique** : lésions gommeuses ascendantes le long du trajet lymphatique de drainage

L'aspect de ces lésions cutanées en chapelet est caractéristique de la sporotrichose (chapelet sporotrichosique).

-une forme cutanée fixe

-une forme **pulmonaire** primaire asymptomatique ou symptomatique, elle peut faire évoquer une tuberculose ou une histoplasmosse de primo infection.

-Les formes **secondaires disséminées** de sporotrichose sont rares ; apparaissent chez le sujet immunodéprimé par dissémination hématogène à partir de foyers cutanés, muqueux ou pulmonaires.

➤ **Diagnostic:**

Prélèvements:

Pus de lésions, les squames ou les croûtes sont prélevés par grattage
Atteinte profonde: biopsies, expectorations, LCR.

Examen direct.

9

colorations de Gram ou MGG .

forme levure appelée «corps en cigare », gram positif, d'environ 5 μ sur 3 μ , ou plus arrondie.

Culture.

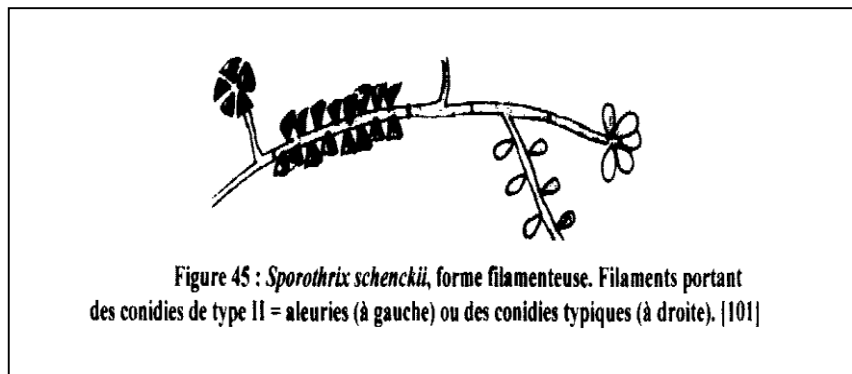
Le délai d'obtention est rapide : 4 à 7 jours. Il est parfois retardé et impose de garder les tubes 4 semaines.

Aspect histologique

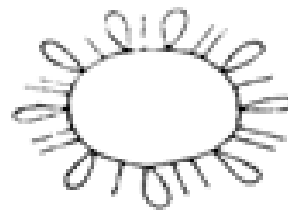
Corps astéroïde ou phénomène de **Splendore-Hoepli** autour de l'élément fongique (coloration HES : hémateïne éosine safran).

Traitement:

- **L'Itraconazole** (sporanox*) est le traitement de choix de la sporotrichose lymphocutanée à raison de 100 à 200 mg /jour pendant 3 à 6 mois , les doses prescrites lors des formes disséminées sont plus fortes(200 à 400 mg pendant 6 à 18 mois)
- Chez le sujet VIH+ les formes généralisées nécessitent un traitement à l'**Amphotéricine B** par voie parentérale, puis on prend le relais par **Itraconazole** 200mg/ jour à vie.



Forme en navette



corps astéroïde

Sporothrix schenckii

